

ЛИСТОВКА



ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Адолорин 300 mg/250 mg/50 mg таблетки
парацетамол/пропифеназон/кофеин

Adolorin 300 mg/250 mg/50 mg tablets
paracetamol/propyphenazone/caffeine

Прочетете внимателно цялата листовка, тъй като тя съдържа важна за Вас информация. Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на Адолорин.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Вие трябва да потърсите лекарска помощ, в случай че Вашите симптоми се влошават или не се подобряват.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

1. Какво представлява Адолорин и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете преди да приемете Адолорин
3. Как да приемате Адолорин
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Адолорин
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Листовка - Приложение 2	
Съгласие №	20140101
Разрешение №	27760 / 20-11-2014
Особение №	

1. Какво представлява Адолорин и за какво се използва

Адолорин таблетки притежава бързо настъпващ обезболяващ и понижаващ температурата ефект.

Адолорин се използва

- за лечение на болезнени състояния като главоболие, зъбобол, ревматични и мускулни болки, болки при менструация.
- за лечение на повишена температура и болка при простуда и грип.

2. Какво трябва да знаете преди да приемете Адолорин

Не използвайте Адолорин

- ако сте алергични (свръхчувствителни) към пропифеназон, парацетамол, кофеин, пиразолови производни или към някоя от останалите съставки на Адолорин. За пълния списък на останалите съставки, вижте точка 6.
- ако имате свръхчувствителност (алергия).
- ако имате увреждане на костния мозък.
- в случай на генетично установена недостатъчност на глюкозо-6-фосфат-дехидрогеназата (наследствено, много рядко метаболитно заболяване).
- в случай на тежки нарушения на бъбречната и чернодробната функция, като сбръчкан бъбрек, или цироза на черния дроб.
- при чернодробна порфирия (наследствен ензимен дефект или придобито метаболитно нарушение).
- в случай на прекомерна и/или хронична алкохолна консумация.
- при главоболие, предизвикано от лекарствени продукти.
- при деца под 12 години.
- по време на бременност и кърмене.



Обърнете специално внимание при употребата на Адолорин

- при нарушения на чернодробната функция.
- при тежки нарушения на бъбречната функция.
- при синдром на Жилберт (наследствено заболяване, при което има повишен билирубин в кръвта и жълтеница).
- при стомашни язви, язви на червата или кървене

Консултирайте се с Вашия лекар ако:

- имате **висока температура**
- имате симптоми на **инфекция**
- симптомите ви продължават повече от 3 дни.

Консултирайте се с лекар преди да вземете Адолорин, ако:

- страдате от **астма** или **хронични инфекции на дихателните пътища** (особено когато са съчетани със симптоми на сenna хрема).
- имате **свръхчувствителност към аналгетици (обезболяващи) или антиревматични лекарства** (аналгетична астма), тъй като съществува риск от шокова реакция.

Риск от бъбречно увреждане:

По принцип редовното приемане на аналгетици (обезболяващи) може да доведе до трайно **бъбречно увреждане** с риск от **бъбречна недостатъчност** (т.нар. аналгетична нефропатия). Това важи особено когато се комбинират няколко обезболяващи лекарства.

Предпазни мерки в случай на продължителна употреба на обезболяващи във високи дози, което не е в съответствие с указанията:

При **продължителна употреба на високи дози обезболяващи, което не е в съответствие с указанията**, може да се появи главоболие. То не трябва да се лекува с по-високи дози от лекарствения продукт. Превияването на препоръчителната доза може да доведе до много тежко чернодробно увреждане.

Ако приложението на обезболяващи се **прекъсне внезапно след продължителна употреба на високи дози, което не е в съответствие с указанията**, могат да се появят главоболие, уморяемост, мускулна болка, нервност, храносмилателни смущения, нарушения на сърдечния ритъм или нарушения на съня. Тези оплаквания преминават за няколко дни. Дотогава не трябва да приемате каквито и да е обезболяващи и трябва да се консултирате с лекар преди да подновите тяхната употреба.

Приемайте лекарствени продукти, които съдържат **само ниски дози кофеин**, ако имате някое от следните състояния:

- нарушение на сърдечния ритъм с повишена сърдечна честота.
- цироза на черния дроб.
- повишена функция на щитовидната жлеза.
- синдром на тревожност.
- язви на стомаха и дванадесетопръстника.

Прием на други лекарства

Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Едновременно приемане на парацетамол

Не приемайте едновременно други лекарствени продукти, които съдържат парацетамол, за да избегнете риска от предозиране.

Повишаване или отслабване на ефекта:

Адолорин таблетки може да повиши или намали ефекта на различни лекарствени продукти. Следователно Адолорин таблетки не трябва да се приема по едно и също време със следните лекарствени продукти, без указанието на лекар:



Повишаване:

- на ефекта на пероралните таблетки за разреждане на кръвта, особено в случай на продължително редовно приемане. Влиянието при случайно приемане е незначително.
- Едновременното приемане на средства, ускоряващи изпразването на стомаха, като метоклопрамид, причинява по-бърза резорбция и ефект на парацетамол.
- образуването на вредни продукти от разграждането от лекарствени продукти, които стимулират активността на черния дроб (напр. барбитурати, антиепилептични средства, рифампицин).
- Приемането на определени лекарствени продукти за понижаване на пикочната киселина (пробенецид) повишава наличността на парацетамол. Следователно дозата на парацетамол трябва да бъде намалена.
- Салициламидите (облекчаващи болката лекарства) могат да доведат до удължаване разграждането на парацетамол и да повишат образуването на вреден продукт от разграждането.
- Кофеин ускорява абсорбцията на определени лекарства за лечение на мигрена (ерготамин).

Намаляване:

- на скоростта на разграждане на определени антибиотици (хлорамфеникол до 5 пъти).
- Холестирамин (лекарствен продукт за понижаване стойностите на масите в кръвта) намалява абсорбцията на парацетамол.

Обърнете особено внимание, ако използвате едновременно лекарствени продукти, които увреждат черния дроб и/или стимулират метаболизма.

Употреба на Адолорин с храни и напитки

Избягвайте едновременната консумация на алкохол, тъй като това повишава увреждащия черния дроб ефект на парацетамол.

Бременност и кърмене

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

Не приемайте Адолорин по време на бременност и кърмене.

Шофиране и работа с машини

Адолорин не повлиява или повлиява пренебрежимо способността за шофиране и работа с машини.

3. Как да приемате Адолорин

Винаги приемайте Адолорин точно според инструкциите в тази листовка. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Ако не е предписано друго от Вашия лекар, обичайната дозировка е следната:

Възрастни и юноши над 12 години:

При необходимост, приемете една таблетка (не повече от 3½ таблетки дневно) с достатъчно количество течност.

Пациенти с нарушена бъбречна или чернодробна функция:

При пациенти с нарушена бъбречна или чернодробна функция, например при синдрома на Жилберт, дозата трябва да бъде намалена. Необходимо е да се спазва по-дълъг интервал между приема на две таблетки. При тежко нарушение на бъбречната функция (креатининов клирънс $< 10 \text{ ml/min}$) интервалът между приема на две таблетки трябва да бъде поне 8 часа.

Продължителност на приемане:

Не приемайте Адолорин повече от 10 последователни дни без консултация с лекар.

Ако сте приели повече от необходимата доза Адолорин



Свържете се с Вашия лекар колкото е възможно по-скоро, тъй като превишаването на препоръчителната доза може да доведе до тежко чернодробно увреждане. Не приемайте други лекарствени продукти, които съдържат парацетамол, за да се избегне риска от предозиране и последващо чернодробно увреждане.

Вашият лекар ще Ви даде антидот колкото е възможно по-скоро и/или ще предприеме други подходящи мерки.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, Адолорин може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

При оценката на нежеланите лекарствени реакции са използвани следните честоти:

Много чести:	засягат повече от 1 на 10 лекувани пациенти
Чести:	засягат от 1 до 10 на 100 лекувани пациенти
Нечести:	засягат от 1 до 10 на 1 000 лекувани пациенти
Редки:	засягат от 1 до 10 на 10 000 лекувани пациенти
Много редки:	засягат по-малко от 1 на 10 000 лекувани пациенти

С неизвестна честота: честотата не може да бъде определена от наличните данни.

Нарушения на имунната система:

Много редки: Алергични реакции на костния мозък (панцитопения, левкоцитопения, тромбоцитопения, агранулоцитоза), определени нарушения на кръвта (метхемоглобинемия), астма, сенна хрема, оток на носната лигавица, реакции на свръхчувствителност (оток на кожата, затруднено дишане, изпотяване, гадене, понижаване на кръвното налягане), тежки реакции на свръхчувствителност (анафилактичен шок).

Психични нарушения:

Редки: Кофеин може да причини нарушения на съня.

Нарушения на нервната система:

Редки: Кофеин може да причини повишено вътречерепно налягане.

Стомашно-чревни нарушения:

Редки: Гадене.

Нарушения на черния дроб и жлъчните пътища

Приемането на високи дози парацетамол (също продължително приемане или хронична употреба на няколко грама дневно) може да доведе до тежко чернодробно увреждане и нарушение на чернодробната функция.

Нарушения на кожата и подкожната тъкан:

Редки: Алергични кожни реакции, които могат да са придружени с повишаване на температурата („лекарствена треска“) и язви по лигавиците.

Нарушения на бъбреците и пикочните пътища:

Приемането на високи дози парацетамол (също продължително приемане или хронична употреба на няколко грама дневно) може да доведе до нарушение на бъбречната функция.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез

Изпълнителна агенция по лекарствата
ул. „Дамян Груев“ № 8
1303 София



Тел.: +359 28903417
уебсайт: www.bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Адолорин

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Да се съхранява под 25°C.

Съхранявайте блистерите в картонената опаковка, за да се предпазят от светлина.

Не използвайте Адолорин след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка след "Годен до:". Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Адолорин

- Активните вещества са: пропифеназон, парацетамол, кофеин.
Една таблетка съдържа: 300 mg парацетамол, 250 mg пропифеназон и 50 mg кофеин.
- Другите съставки са: микрокристална целулоза, повидон, талк, магнезиев стеарат, кросповидон.

Как изглежда Адолорин и какво съдържа опаковката

Адолорин таблетки са бели, кръгли, двойно-изпъкнали таблетки и се предлагат в блистерни опаковки от 10, 20, 30 или 50 таблетки.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Kwizda Pharma GmbH
Effingergasse 21
A-1160 Vienna
Австрия

За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба.

Прескрипция ЕООД

бул. "Христо Ботев" 28, ет. 5, офис 8
София 1000
телефон: +359 2 943 47 73
факс: +359 2 943 42 25
имейл: office@prescriptia.com

Дата на последно одобрение на листовката {мм /гггг}.



Посочената по-долу информация е предназначена само за медицински специалисти:

Предозиране

Симптоми:

Пропифеназон и кофеин:

В случай на тежко предозиране могат да се наблюдават сънливост или безсъзнание, нарушено зрение, гърчове, епилептичен статус, алергични състояния, агранулоцитоза, свръхвъзбуда и сърдечна аритмия. Симптоми на интоксикация могат да настъпят от 1 g (или повече) кофеин, ако е абсорбиран за кратко време.

Парацетамол:

Съществува риск от интоксикация, особено при по-стари хора, малки деца, индивиди с чернодробно заболяване, хронична алкохолна злоупотреба, хронично недोхранване, и когато се приемат по същото време лекарствени продукти, водещи до ензимна индукция. В тези случаи предозирането може да бъде фатално. Като правило, симптоми като гадене, повръщане, анорексия, бледност и болка в долната част на корема, настъпват в рамките на 24 часа. След това може да настъпи подобрене на субективното състояние, но остава лека абдоминална болка като индикация за чернодробно увреждане.

Предозиране с приблизително 6 g или повече парацетамол като индивидуална доза при възрастни води до некроза на чернодробните клетки, което може да доведе до пълна и необратима некроза и след това до хепатоцелуларна недостатъчност, метаболитна ацидоза и енцефалопатия. На свой ред тя може да доведе до кома, също с фатален изход. В същото време се наблюдават повишени концентрации на чернодробните трансаминази (AST, ALT) лактат-дехидрогеназата и билирубина, в комбинация с повишено протромбиново време, което настъпва 12 до 48 часа след приемането. Като правило, клиничните симптоми на чернодробното увреждане се проявяват след 2 дни и достигат максимум след 4 до 6 дни. Дори и ако няма тежко чернодробно увреждане, може да настъпи остра бъбречна недостатъчност с остра тубуларна некроза.

Сред другите симптоми, независими от черния дроб, които са наблюдавани след предозиране с парацетамол, са миокардни нарушения и панкреатит.

Терапевтични мерки в случай на предозиране:

Дори когато се подозира интоксикация с парацетамол, интравенозното приложение на донори на SH-група като N-ацетилцистеин в рамките на първите 10 часа, се счита за разумно. N-ацетилцистеин в рамките на първите 10 часа, напр. Mucomyst разтвор (перорално: начална доза 140 mg/kg телесно тегло, след 8 часа поддържащи дози от 70 mg/kg телесно тегло на всеки 4 часа).

N-ацетилцистеин може все още да упражнява определена защита дори след 10 до 48 часа. В този случай се извършва по-продължително приемане. При пациенти с анамнеза за астма трябва да се има предвид, че може да се провокира астматичен пристъп при лечение с N-ацетилцистеин. Плазмената концентрация на парацетамол може да бъде намалена чрез диализа. Препоръчва се определяне на плазмената концентрация на парацетамол.

По-нататъшната възможна терапия при предозиране на Адолорин трябва да се ръководи от степента, етапа и клиничните симптоми в съответствие с обичайните мерки при интензивно лечение.

